Triaje en servicios de urgencias

Objetivo del triaje

El triaje clasifica a los pacientes que llegan a urgencias según la gravedad de su estado, no según el orden de llegada. Su propósito es que quien corre mayor riesgo vital sea atendido primero y que el tiempo de espera de cada paciente sea seguro para su condición.

Niveles de prioridad

Los sistemas de triaje estructurado usan cinco niveles. El nivel 1 corresponde a la atención inmediata, como un paro cardiorrespiratorio. El nivel 2 es muy urgente, con un tiempo objetivo de 10 minutos. El nivel 3 es urgente, con 60 minutos. El nivel 4 es menos urgente, con 120 minutos, y el nivel 5 no urgente, con 240 minutos.

Evaluación inicial

La enfermera de triaje registra el motivo de consulta y los signos vitales: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. También valora el nivel de conciencia y el dolor con una escala de 0 a 10. La evaluación debe completarse en pocos minutos para no retrasar la atención.

Reevaluación

La prioridad asignada no es definitiva. Si un paciente espera más que el tiempo objetivo de su nivel, o si sus síntomas cambian, debe reevaluarse. Un paciente puede subir de nivel cuando empeora, por ejemplo si aparece dificultad respiratoria.

Errores frecuentes

El error más grave es la infraclasificación: asignar a un paciente un nivel menos urgente que el que le corresponde. También es un problema la sobreclasificación, porque ocupa recursos de atención inmediata con pacientes que podrían esperar con seguridad.